

Soome sotsiaaltöös ja sotsiaaltöö koolituses on toimumas suured muutused



Anneli Pohjola

Sotsiaaltöö professor, Lapi Ülikool

Soome riikliku sotsiaaltööd õpetavate ülikoolide võrgustiku Sosnet vastutav koordinaator

Kavas on lõimida sotsiaal- ja tervishoiuteenused ning suunata vastutus nende loomise ja korraldamise eest maakondadele. Muutused on toimumas ka sotsiaaltöö kutsenõuetes ja erialases koolituses.

Soomes on käimas sajandi suurimaks reformiks nimetatud ümberkorraldus sotsiaal- ja tervishoiussüsteemis. Valitsuse novembrikuise sihiseade kohaselt soovitakse lõimida sotsiaal- ja tervishoiuteenused ning suunata vastutus nende loomise ja korraldamise eest valdadel maakondadele. See toob endaga kaasa maakondliku haldustasandi tugevdamise, aga ka maakondlikud valimised; rahastus tuleb riigilt, kuid see, kuidas see täpselt toimuma hakkab, nagu ka paljud teised reformi praktilise poolega seotud küsimused, pole veel otsustatud. Alates 2019. aasta algusest peavad kaheksateist maakonda¹ hoolitsema sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osutamise eest oma piirkonnas, neist kaheteistkümmes avaneb võimalus saada erakorralist sotsiaal- ja arstiabi ööpäevaringselt. Maakondlike teenuste osutamist hakkab koordineerima sotsiaal- ja tervise-ministeerium. Need otsused sätestatakse ettevalmistatavas hoolekande ja tervishoiu korralduse seaduses.

Uuendused sotsiaal- ja tervishoiuteenuste korralduses

Sotsiaaltöö on osa suurtest muudatustest. See tähendab, et tuleb muuta kogu praegu toimivat sotsiaaltöö töökeskkonda ja teenuste struktuuri. Sotsiaaltöö liigub uute maakondlike hoolekande- ja tervishoiuasutuste haldusalasse. Samas tuleb teha tihedat koostööd valdadega, kelle ülesandeks jäävad ka edaspidi sotsiaalse heaolu ja tervise edendamine, sotsiaalprobleemide ennetamine ja muud vallaelanike heaolu mõjutavad toimingud nagu põhi- ja kutsehariduse ning noorsootöö korraldamine, tööhõive suurendamine, piirkondade ruumiline planeerimine jm.

Vastavalt teenuste lõimimise kavale lisanud palju ühistööd tervishoiuga. Muutusi toob endaga kaasa ka see, et varem valdade sotsiaaltöötajatele rohkesti tööd andnud toimetulekutoetuse maksmine läheb üle

¹ Sotsiaal- ja tervishoiuteenuste reform käib käsikäes haldusreformiga. 1. mai 2016 seisuga oli Soomes 19 maakonda, mis jagunevad 313 vallaks. Valitsuse plaani kohaselt on 2019. aastast riigis 18 maakonda. Lisaks sotsiaal- ja tervishoiuteenuste korraldamisele hakkavad maakonnad täitma ka teisi ülesandeid, näiteks vastutama päästeteenuste eest. – toim.

Sotsiaalkindlustusametile (Kela)². Tänu sellele jääb sotsiaalhoolekande osakondadel rohkem aega, et keskenduda kohaliku sotsiaaltöö uuendamisele ja klientide sotsiaalsele rehabilitatsioonile.

Sotsiaaltöö peaks kujunema kogu sotsiaalvaldkonna teenuste eestvedajaks nii nagu arstiteadus on seda tervishoius. See toob kaasa vajaduse suurte muudatuste järele nii teenuste kui ka koolituse ja uurimistöö arendamises. Praegused sotsiaalteenused ei ole liigitatud neile esitatavate nõuete taseme alusel, uue teenuste struktuuri väljatöötamisel aga hakatakse mõtlema ka sellele, milline võiks olla esmatasandi ja spetsialiseeritud teenuste optimaalne suhe. Sotsiaaltöös on pikka aega puudunud läbiuuritud töömeetodid erinevalt tervishoiust, kus kasutatakse tõenduspõhiseid nn „sobiva hoolduse” ravijuhiseid.³ Eelseisvat arendustööd raskendab see, et sotsiaal- ja tervishoiuteenuste uuendamist teostatakse eeskätt tervise vaatevinklist, sotsiaalse mõõtme maksmapanekuks tuleb teha palju selgitustööd.

Nõuded sotsiaaltöö kompetentsidele uuenevad

Muutub nõuab nii sotsiaaltöökoolituse kui ka sotsiaaltöötaja põhi- ja erikompetentside uut moodi liigendamist. Teadmata on, millised erikompetentsid osutuvad tulevikus hoolekandes ja tervishoius vajalikuks. Riiklikus sotsiaaltööd õpetavate ülikoolide võrgustikus Sosnet oleme vestelnud sotsiaaltöökoolituse tulevikuväljavaadetest. On ilmne, et arvestades digitaliseerumist kasvab vajadus infotehnoloogialase võimekuse järele, samuti läheb majandusraskuste korral ühiskonnas enam tarvis sotsiaalmajanduslikke teadmisi. Seoses

ühiskonna mitmekesisustumisega vajatakse traditsiooniliste sotsiaaltööoskuste kõrval sotsiaalsete õiguste paremat mõistmist. Ka uurimisoskused muutuvad üha tähtsamaks, kuna teenuste arendamise eelduseks on tugeva teadusliku baasi olemasolu.

Kõik seadusemuudatused ja uuendused peavad aitama ellu viia kliendist lähtumise põhimõtet ning tagama klientide suurema osaluse teenuste arendamisel.

Lisaks ühiskonna ja teenuste struktuuri muutustele on märkimisväärselt uuenenud sotsiaaltööd puudutavad õigusaktid. Eelmisel aastal jõustus uus sotsiaalhoolekande seadus (soome k *sosiaalihuoltolaki*), mis on sotsiaalvaldkonna keskne seadus, ja see muutus kajastub mitmes muus seaduses. Päris uued tegevusvaldkonnad sotsiaalhoolekande seaduses on näiteks sotsiaalne rehabilitatsioon ja struktuurne sotsiaaltöö, mis toovad uusi olulisi teemasid sotsiaaltöötaja pädevusnõuetesse. Kõik seadusemuudatused ja uuendused peavad aitama ellu viia kliendist lähtumise põhimõtet ja tagama klientide suurema osaluse teenuste arendamisel. Struktuurse sotsiaaltöö (soome k *rakenteellinen sosiaalityö*) ülesanne on muuhulgas sotsiaalse õigluse ja võrdse kohtlemise edendamine, kodanike osaluse tagamine teenuste osutamisel ja arendamisel, hoolekandeteenuste strateegiate ning teenuseid puudutavate otsuste mõjutamine ja erialaste teadmiste loomine. Seega peavad kõik seadusemuudatused ja uuendused aitama ellu viia kliendist lähtumise põhimõtet ja

² Muudatus jõustub 1. jaanuarist 2017. – Indira Viiralt-Nummela

³ Soome arstide liit Duodecim töötas koostöös mitme eriarstide organisatsiooniga välja uurimistulemustele rajanevad riiklikud ravijuhised, mis on tuntud „sobiva hoolduse” (soome k *käyppä hoito*) nime all ja on mõeldud kasutamiseks nii patsientidele kui spetsialistidele. – Indira Viiralt-Nummela.

tagama klientide suurema osaluse teenuste arendamisel.⁴

2016. a märtsis jõustus uus sotsiaalhoolekande kutseseadus (soome k *sosiaalihuollon ammattihenkilölaki*), mis tugevdab sotsiaalvaldkonna spetsialistide positsiooni ja tõstab nende tegevust puudutava järelevalve⁵ samale tasemele tervishoiu spetsialistidega, kellele vastav seadus on kehtinud juba pikka aega⁶. Sotsiaalhoolekande kutseseadusega kehtestatud pädevusnõuete kohaselt peab sotsiaaltöötaja olema läbinud magistriõppe, milles sisaldasid või millele lisandusid ülikooliõpingud, kus peaaineks sotsiaaltöö. Regulasioon on jäänud samasuguseks, kui see oli juba 2005. a sotsiaalhoolekande kutsealade seaduses, st sotsiaalhoolekande spetsialisti pädevus põhineb magistriõpingutel ülikoolis. Uus aga on näiteks see, et seaduse § 9 kirjeldatakse üksikasjalikult sotsiaaltöötaja spetsiifilisi kohustusi:

„Sotsiaaltöötaja vastutab sotsiaaltöö professionaalse juhtimise eest nii üksikisikutele, peredele kui kogukonnale sotsiaalse toe ja teenuste vajaduspõhisel pakkumisel sotsiaaltöö klienditöös ja kutsetöös kui ka selle mõjude jälgimise ja hindamise eest. Sotsiaaltöötaja vastutab lisaks hoolekandeteenuste osutamisele ka otsuste tegemise eest kooskõlas sellega, kuidas see on reguleeritud teiste seadustega.”

Kohustuste määratlemine muudab juhtimiskompetentsid üheks peamiseks sotsiaaltöö pädevusvaldkonnaks. Samuti on sotsiaaltöötaja ülesanne ka teenuste mõju jälgimine ja hindamine. Info ja muutuste juhtimine, nagu

ka mõju hindamine eeldab terviklähenemist ja häid uurimisosi. Sotsiaaltöökoolituse arendamisel lähtutakse Soomes juba pikemat aega uurimispõhise sotsiaaltöö põhimõtetest.

Sotsiaaltöö erioskuste tagamine

Sotsiaaltöötajate spetsialiseerumiskoolitusi korraldab Soomes 2000. aastast riiklik ülikoolivõrgustik Sosnet. Spetsialiseeruda sai viies valdkonnas, magistriõpingute ning töökogemuse omandamise järel tuli õppuril kaitsta töö kõrvalt nelja aasta jooksul erialane litsentsiaaditöö mahuga 120 EAP. 2015. aastal uuendas haridus- ja kultuuriministeerium kõigi kutsealade spetsialiseerumiskoolitust puudutavad õigusaktid, mis sundis muutma ka sotsiaaltöö puhul hästi toimivat spetsialiseerumiskoolitust. Uus spetsialiseerumiskoolitus ei ole enam tasemekoolituse osa. See on lisatud kõrgkooliseadusesse uue õppevormina kõrgkooliõpingute ja täiendusõppe vahele. Uus on ka see, et õpe on muutunud tasuliseks: iga õppija või tema töandja peab maksma koolituse eest õppemaksu, mis võib olla kuni 120 eurot ainepunkti eest. Osaliselt toetab koolitust haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt ülikoolidele suunatav tulemusrahastus.

Uues vormis toimuv sotsiaaltöötajate spetsialiseerumiskoolitus valmistati ette ülikoolide ühistööna Sosneti juhtimisel. Neli uut spetsialiseerumisvaldkonda sotsiaaltöös on: 1) laste-, noorsoo- ja peresotsiaaltöö; 2) rehabiliteeriv sotsiaaltöö; 3) struktuurne sotsiaaltöö ja 4) hoolekande- ja heaoluteenuste

⁴ Näiteks tuleb vastavalt uuele Soome sotsiaalhoolekande seadusele hinnata iga sotsiaalhoolekande osakonda pöördunud kliendi puhul teenuste vajadust, et selgitada, kas inimene vajab ühekordset, korduvat või pikaajast teenust, sarnaselt sellele nagu tervishoius koostatakse igale patsiendile raviplaani. – Indira Viiralt-Nummela.

⁵ Järelevalvet sotsiaalvaldkonna spetsialistide tegevuse üle teostab VALVIRA (*Sosiaali- ja terveystalantide lupa ja valvontavirasto*, tervise ja sotsiaalvaldkonna litsentseerimise ja järelevalve asutus) – Indira Viiralt-Nummela.

⁶ Sotsiaaltöö kuulub Soomes seadusega reguleeritud kutsealade hulka, mille puhul nõutakse kutsealal tegutsemise õigust. – toim.

arendamine. Koolituse maht on 70 EAPd ja see kestab kaugõppes 2,5–3 a. Ülikoolide kehtestatud õppemaks on 50 eurot ühe EAP eest. Sisu koosneb spetsialiseerumisvaldkonna õpinguist, uurimis- ja metodoloogiaõpinguist ning praktikaga seotud uurimuslikust arendusülesandest. Korraga võetakse vastu 20–24 õppurit igale spetsialiseerumisvaldkonnale, esimesed koolitused algavad juba 2016. aastal.

Spetsialiseerumiskoolituse läbinud sotsiaaltöötajad on uuenevatele sotsiaal- ja tervishoiuteenustele oluline jõuvaru. Sotsiaaltöö ülesanded on ulatuslikud ja mitmesuunalised, süvendatud erioskusi vajatakse erilist tuge vajavate klientide ja olukordade puhul, sotsiaaltöö juhtimisel ja teenuste terviklikul arendamisel. Sageli asuvad spetsialiseerunud sotsiaaltöötajad juba koolituse ajal tööle nõudlikumatesse töövaldkondadesse. Siiski puudub Soomes siiani spetsialiseerunud töötaja seaduslik tunnustamine, pole ka spetsialiseerunud töötajaid nõudvate ametikohtade loetelused. See on suur väljakutse hoolekandele ja tervishoiule, sest samal ajal põhinevad praktiliselt kõik arstide ametikohad spetsialiseerumiskoolitusel; arstidel on kokku 50 spetsialiseerumisvaldkonda.

Muudatused sotsiaaltöö koolitajate koostöös tööandjatega

Hoolekande ja tervishoiu reform mõjutab ka sotsiaaltöö koolitajate suhteid tööandjatega. Tudengite õppepraktika ja õppeülesannete sidumiseks uute teenustega tuleb sõlmida uusi lepinguid. Uute teenusepakujate uurimisvajaduste lisandumine ja nende vastuvõtmine

ülikoolide poolt nõuab osalt uusi koostöösuhteid. Suureks küsimuseks ongi, milline saab olema ülikoolide pakutava sotsiaaltöökoolituse ja uurimistöö koht tulevastes maakondlikes sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid korraldatavates organisatsioonides ja viie ülikooli haigla juurde rajatavates suuremates üksustes⁷, mille ülesandena nähakse lisaks kõigi spetsialiseeritud teenuste osutamisele ka koolituse, uurimise ja arendustöö koordineerimist oma piirkonnas. Toimivate koostöösuhete loomiseks oleks ülikoolide sotsiaaltööõppel oluline saavutada kindel koht ka hoolekande- ja tervishoiuteenuseid osutavates piirkondlikes organisatsioonides.

Laiemalt puudutab see koolituse, uurimise ja arendamise koha määramist tervikuna. Soomes on 21. sajandi algusest sotsiaaltöö kompetentsikeskused olnud olulised piirkondade ja valdade sotsiaaltöö arendajad ning ülikoolide koostööpartnerid. Sotsiaal- ja tervishoiuteenuste uuendamisel tuleb sotsiaaltööga tegelevates organisatsioonides luua koostöös ülikoolidega ühtne koolituse, uurimise ja arendamise struktuur, seda nii maakondlikes kui ka piirkondlikes sotsiaal- ja tervishoiuasutustes, aga ka ülikoolihaiglates, ning seda ühistööd on vaja ka edaspidi arendada.

Niisiis on sotsiaaltöö ja sellealane koolitus Soomes tõepoolest pöördeliste muutuste keskel. Me ei suuda isegi kujutleda, mida kõike need muudatused kaasa toovad. Siiski võib muudatusi pidada võimaluseks arendada uut laadi sotsiaaltööd ja tugevdada sotsiaaltöö positsiooni ühiskonnas. S

Tõlkinud soome keelest Anne Tiko

⁷ Ülikoolihaiglad hakkavad osutama kõrgema taseme spetsialiseeritud hoolekande- ja tervishoiuteenuseid. Käivad arutelud ka selle kohta, kas tulevikus võiksid nad hakata koordineerima ka tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna uurimis- ja arendustegevust – autor.